PFE - Pleito de Financiamento Externo
Reorganização e Expansão a garantir o Direito à Saúde em João Pessoa - REDS+JP

Proponente: Município de João Pessoa
Processo SEI: 03101.000071/2026-18
Código do pleito: 2333990427/2026
Versão: 1

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 99.200.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 24.800.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 10
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 5. Componentes 11
1. 5. 1. Informações do 1° componente 11
1. 5. 2. Informações do 2° componente 20
1. 5. 3. Informações do 3° componente 23
1. 6. Beneficiários 26
1. 7. Anexos 27
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 28
2. 1. Áreas estratégicas 28
2. 2. Anexos 30
3. GESTÃO 31
3. 1. Arranjo institucional 31
3. 1. 1. Descrição 31
3. 1. 2. Orgãos Executores 32
3. 1. 3. Estrutura Operacional 32
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 35
3. 2. Operacionalização e Manutenção 35
3. 3. Planejamento Estratégico 36
3. 4. Anexos 37
4. RISCOS 38
4. 1. Informações do 1° risco 38
4. 2. Informações do 2° risco 38
4. 3. Informações do 3° risco 38
4. 4. Informações do 4° risco 38
4. 5. Informações do 5° risco 39
4. 6. Informações do 6° risco 39
4. 7. Informações do 7° risco 39
4. 8. Anexos 39
5. FINANCIAMENTO 40
5. 1. Condições Financeiras da Operação 40
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 40
5. 2. Cronograma de Desembolso 41
5. 3. Contragarantias 42
5. 4. Anexos 42
6. ETAPAS REALIZADAS 43

6. 1. Etapas realizadas 43
6. 2. Anexos 43
7. CONTATOS . . . . . .
7. 1. Contatos . . . . . .
7. 2. Anexos . . . . . .
8. Baixar todos os anexos 45
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Reorganização e Expansão a garantir o Direito à Saúde em João Pessoa - REDS+JP
Sigla: REDS+JP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de João Pessoa

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, é o principal polo urbano, econômico, político-administrativo e assistencial da 1ª Macrorregião de Saúde, desempenhando papel estratégico na oferta de serviços de média e alta complexidade para a população local e para municípios vizinhos. Com mais de 830 mil habitantes e posição central na organização do sistema de saúde estadual, a cidade concentra hospitais próprios, filantrópicos e contratualizados, além de serviços de referência em diversas especialidades. Essa centralidade, entretanto, traz crescente demanda por serviços, pressionando a capacidade da rede municipal.

Do ponto de vista sociodemográfico, João Pessoa atravessa um processo de transição populacional acelerada. O índice de envelhecimento saltou de 31,6 em 2010 para 52,2 em 2022, o que representa 52 idosos para cada 100 crianças e adolescentes. Essa mudança demográfica amplia a prevalência de doenças crônicas, aumenta a necessidade de cuidados prolongados, reabilitação, atenção geriátrica e serviços especializados, impactando a estrutura e os custos do sistema de saúde. Ao mesmo tempo, persistem desigualdades territoriais e socioeconômicas, com bolsões de vulnerabilidade que interferem na equidade do acesso e nos resultados em saúde.

No campo epidemiológico, os dados evidenciam desafios relevantes. Em 2025, João Pessoa registrou 15 óbitos maternos, representando mais da metade das mortes do estado. A mortalidade infantil, embora tenha apresentado tendência de redução ao longo da última década, mostra instabilidade no componente pós-neonatal, com aumento expressivo em 2022, sugerindo fragilidades no acompanhamento após a alta hospitalar. Quanto ao perfil de internações (2018–2025), observa-se predominância da faixa etária de 15 a 49 anos (49%) e pessoas com mais de 50 anos (37%), confirmando alta demanda de adultos em idade produtiva e idosos nos serviços hospitalares.

A análise da produção hospitalar entre 2018 e 2025 demonstra queda no valor médio mensal, aumento do tempo médio de permanência (6,2 dias, acima das médias estadual e nacional) e elevação da taxa de mortalidade (4,81%, superior à média do Nordeste). Além disso, 54,2% das internações em 2024 foram de urgência, contrariando as diretrizes do SUS, que preveem a atenção primária e especializada organizada como principal porta de entrada, de forma eletiva. Esse dado sinaliza baixa resolutividade pré-hospitalar, insuficiência de retaguarda e dificuldades na regulação de leitos.

No aspecto assistencial, destacam-se gargalos nas áreas de oncologia, cardiologia, saúde materno-infantil, ortopedia, e diagnóstico por imagem. A demanda reprimida, o tempo de espera elevado, a escassez de leitos em áreas críticas e a fragmentação entre os níveis de atenção indicam limitações na capacidade instalada e nos fluxos assistenciais.

No eixo da infraestrutura, diversas unidades hospitalares próprias (ex.: Hospital Municipal Santa Isabel, Complexo Hospitalar de Mangabeira, Hospital Municipal Valentina) apresentam estruturas físicas e equipamentos desatualizados. Além da unidade estratégica, hoje, toda custeada pelo município, como o antigo Hospital Prontovida (atual Hospital Geral e do Câncer).

No contexto estadual, João Pessoa concentra parte expressiva das internações de média e alta complexidade, assumindo papel de referência regional. Essa sobrecarga decorre da insuficiência de retaguarda em municípios vizinhos e da concentração de serviços na capital. Assim, a pressão sobre a rede municipal não é apenas local, mas também regional, exigindo maior capacidade instalada, integração entre níveis de atenção e fortalecimento da governança.

Do ponto de vista organizacional, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passou por atualização de seu organograma em 2025, após quase duas décadas sem revisões estruturais. Esse movimento indica reconhecimento institucional das mudanças no perfil assistencial e das exigências legais e de governança. Apesar disso, a infraestrutura física da sede é inadequada às novas demandas, e setores estratégicos, como o Complexo Regulador e a Vigilância Sanitária, funcionam de forma fragmentada, em espaços alugados ou improvisados, sem condições logísticas e tecnológicas adequadas.

Em síntese, João Pessoa se insere em um contexto de crescente demanda por serviços de saúde, marcado por transição demográfica acelerada, pressões assistenciais complexas, infraestrutura hospitalar desigual, desafios na gestão de fluxos e necessidade de modernização institucional. Essa combinação de fatores impacta diretamente a eficiência, a qualidade e a sustentabilidade do sistema municipal de saúde, configurando uma realidade que requer análise aprofundada dos problemas, de suas causas e consequências, juntamente com a adoção de estratégias inovadoras de financiamento e gestão. Nesse cenário, o financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apresenta-se como instrumento essencial para viabilizar um salto qualitativo e estrutural na rede municipal de saúde, permitindo assim, alavancar investimentos estratégicos de médio e longo prazo, com impacto direto na eficiência operacional, na qualidade assistencial e na sustentabilidade fiscal do sistema de saúde

de João Pessoa.

1. 2. 2. **Problema:**

A rede municipal de saúde de João Pessoa apresenta um conjunto de problemas estruturais, assistenciais e institucionais que comprometem a capacidade do sistema em assegurar acesso oportuno, qualidade do cuidado, resolutividade e sustentabilidade. Esses problemas são interdependentes, acumulados historicamente e agravados pelas mudanças demográficas e epidemiológicas, resultando em impactos diretos na população e na eficiência da gestão.

1. Problemas assistenciais

- Filas e demora no acesso a consultas especializadas, cirurgias e exames de diagnóstico por imagem.
- Demanda reprimida em áreas críticas como oncologia, cardiologia, ortopedia e saúde mental.
- Predominância de internações de urgência (54,2%), indicando falhas no acesso eletivo e na organização pré-hospitalar.
- Taxa de mortalidade hospitalar elevada (4,81%), acima das médias regional e nacional.
- Tempo médio de permanência prolongado (6,2 dias), refletindo baixa resolutividade e dificuldades na transição do cuidado.
- Fragmentação dos fluxos assistenciais, com falhas na referência e contrarreferência entre APS, urgência, especializada e hospitais.
- Sobrecarga de UPAs e serviços de urgência, utilizada como porta de entrada principal devido à falta de alternativas estruturadas.

2. Problemas de infraestrutura física e capacidade instalada

- Hospitais próprios desatualizados, com limitações de espaço, layout inadequado conforme legislação para seguir com habilitações.
- Hospital Geral e do Câncer, prédio locado, com assistência toda custeada pelo município, que enfrenta impedimentos jurídicos para habilitação no SUS, em que não se pode adequar, estando o prédio para leilão, tendo que encerrar o funcionamento do mesmo.
- Insuficiência de leitos em áreas de alta demanda, especialmente em oncologia, cardiologia e materno-infantil.
- Estrutura física da Base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) inadequada, com limitações de espaço, ausência de áreas padronizadas para higienização e manutenção de ambulâncias, condições precárias para o repouso das equipes e carência de infraestrutura tecnológica e logística. Essa situação compromete a segurança operacional, o tempo-resposta às ocorrências e o conforto dos profissionais, além de afetar a articulação com as demais unidades da Rede de Atenção às Urgências.
- Ausência de serviços essenciais na rede própria, como Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), Centro de Hemodiálise e unidades especializadas para autismo e idosos.

- Dependência de prestadores filantrópicos e privados, tanto para leitos quanto para procedimentos de média e alta complexidade.

3. Problemas de gestão, regulação e organização da rede

- Complexo Regulador fragmentado, distribuído em prédios alugados ou improvisados, sem estrutura para funcionamento contínuo e integrado.
- Baixa articulação entre níveis de atenção, reforçando a fragmentação assistencial e a sobrecarga hospitalar.

4. Problemas institucionais e organizacionais

- Estrutura física da SMS inadequada, com espaços insuficientes para setores técnicos, administrativos e atendimento ao público.
- Organização institucional em processo de transição, com implementação recente de novo organograma, ainda sem infraestrutura compatível.
- Carência de ambientes apropriados para planejamento, gestão e educação permanente.
- Capacitação profissional insuficiente ou não sistematizada, especialmente em gestão, inovação e uso de tecnologias em saúde.

Causas estruturais e históricas dos problemas

- Crescimento populacional e envelhecimento acelerado, sem expansão proporcional da rede assistencial.
- Mudanças no perfil epidemiológico, com aumento de doenças crônicas e casos complexos.
- Perda de maternidades de referência para a gestão estadual, reduzindo a capacidade instalada municipal.
- Investimentos historicamente concentrados na atenção básica e urgência, com menor foco em média e alta complexidade.
- Dependência de contratos com prestadores externos, dificultando autonomia e sustentabilidade financeira.
- Infraestrutura hospitalar antiga, construída com padrões que não atendem às exigências atuais de segurança, fluxo e tecnologia.

Consequências atuais e futuras, caso o quadro não seja revertido

- Ampliação das filas e da demora no acesso a serviços essenciais.
- Aumento da mortalidade no eixo pré hospitalar e hospitalar.
- Sobrecarga de UPAs e hospitais com casos que poderiam ser resolvidos em outros níveis.

- Maior tempo de permanência hospitalar, ocupando leitos e gerando custos adicionais.
- Crescimento da dependência da rede privada e filantrópica, com menor controle público sobre a assistência.
- Risco de colapso em áreas críticas, principalmente: oncologia, cardiologia e nefrologia.
- Desigualdades no acesso, afetando principalmente idosos, gestantes, pessoas com doenças raras ou crônicas e populações vulneráveis.
- Ineficiência na alocação de recursos públicos, com desperdícios e glosas por falhas de registro ou faturamento.
- Dificuldade de atender às diretrizes do SUS, do PPA e dos órgãos de controle.
- Perda de capacidade estratégica do município como referência estadual, prejudicando toda a macrorregião.

Em síntese, a situação atual é marcada por um sistema de saúde municipal pressionado por demandas crescentes, infraestrutura insuficiente, fragilidades na organização e gestão, dependência de prestadores externos e ausência de mecanismos robustos de monitoramento e avaliação. Esses fatores comprometem a resolutividade, a equidade e a sustentabilidade do sistema, configurando uma realidade que necessita ser transformada por meio de intervenções estruturantes, institucionais e organizacionais (a serem detalhadas nos capítulos seguintes).

1. 2. 38. **Solução:**

As soluções propostas foram definidas para responder de forma direta, estruturante e integrada às fragilidades identificadas no acesso aos serviços, na capacidade instalada, na infraestrutura física, na organização da rede, na gestão institucional e na atenção a populações vulneráveis. As ações priorizam a ampliação da oferta pública, a modernização dos espaços assistenciais e administrativos, a reorganização dos fluxos de cuidado e o fortalecimento da capacidade de gestão e governança do sistema municipal de saúde. Tais soluções estão alinhadas às diretrizes do SUS e aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027, em especial aos eixos de saúde, inclusão, equidade, fortalecimento institucional e modernização.

O projeto REDS+JP, também, alinha-se às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), ao Plano Municipal de Saúde (2022–2025), e ao Plano de Governo da Prefeitura de João Pessoa (2025-2028), atendendo aos princípios da regionalização, integralidade e eficiência previstos na Constituição Federal (art. 198) e na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990).

1. Ampliação e reorganização da capacidade assistencial

Para superar limitações relacionadas ao acesso oportuno, à demanda reprimida por serviços especializados e à baixa resolutividade hospitalar, serão adotadas ações voltadas à expansão e reorganização da oferta assistencial pública. Entre as principais soluções, destacam-se:

- Ampliação de leitos de internação em áreas críticas de média e alta complexidade;
- Disponibilização de serviços especializados na rede própria, reduzindo filas e dependência de prestadores externos;
- Melhoria da capacidade diagnóstica e terapêutica com oferta pública de exames e serviços de apoio clínico;
-

Estruturação de unidades assistenciais com perfis definidos, permitindo melhor organização dos fluxos e hierarquização da rede.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Ampliar o acesso à saúde pública de qualidade.
OE 106 – Promover direitos humanos e inclusão social.
OE 111 – Investimentos em equipamentos sociais nas cidades.

2. Modernização, construção e requalificação da infraestrutura física de saúde

Diante da defasagem estrutural de hospitais, da inadequação de espaços e da ausência de unidades especializadas, serão implementadas soluções que promovem a modernização da infraestrutura física e tecnológica, incluindo:

- Requalificação e ampliação de unidades hospitalares existentes para adequação funcional, sanitária e tecnológica;
- Construção de novas estruturas assistenciais voltadas a serviços de alta complexidade e perfis específicos de atendimento;
- Implantação de unidades especializadas (diagnóstico por imagem, hemodiálise, geriatria, TEA);
- Adequação de ambientes segundo normas de acessibilidade, segurança e padronização de fluxos assistenciais.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Fortalecimento do SUS.
OE 111 – Infraestrutura social e urbana sustentável.
OE 113 – Qualidade de vida e bem-estar.

3. Estruturação da regulação e integração da rede de atenção

Para enfrentar a fragmentação entre níveis de atenção, a baixa integração dos sistemas e as dificuldades na gestão de filas e leitos, serão implementadas ações voltadas ao fortalecimento da regulação e à integração dos serviços, tais como:

- Estruturação de uma instância reguladora centralizada e moderna, com atuação em tempo real;
- Integração tecnológica entre atenção primária, especializada, urgência e hospitais;
- Padronização de protocolos regulatórios e clínicos para garantir continuidade do cuidado;
- Melhoria do monitoramento de leitos, filas e encaminhamentos, com suporte de ferramentas digitais.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Eficiência no Sistema Único de Saúde.
OE 302 – Fortalecimento da capacidade estatal para prestação de serviços públicos.
OE 303 – Transformação digital do governo.

4. Fortalecimento da gestão, governança e capacidade institucional

Para superar limitações estruturais e organizacionais da Secretaria Municipal de Saúde, serão adotadas soluções que modernizam a gestão e aprimoram a governança institucional, incluindo:

- Adequação e modernização da sede administrativa da saúde às novas funções e responsabilidades organizacionais;

- Estruturação de espaços específicos para planejamento, gestão, capacitação, inovação e monitoramento;
- Integração entre áreas estratégicas como planejamento, regulação, auditoria e atenção hospitalar;
- Aprimoramento da gestão de pessoas, logística, farmácia e suporte administrativo-operacional.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Qualidade na gestão do SUS.
OE 302 – Aperfeiçoamento das capacidades estatais.
OE 303 – Digitalização e modernização dos processos públicos.

5. Expansão da atenção a populações vulneráveis e grupos prioritários

Considerando o envelhecimento acelerado da população, o aumento das condições crônicas e a necessidade de inclusão de pessoas com necessidades específicas, serão adotadas soluções que promovem equidade e cuidado integral, tais como:

- Implantação de unidades especializadas para idosos e pessoas com transtorno do espectro autista;
- Ampliação da oferta de serviços contínuos e de reabilitação;
- Adequação da rede às necessidades de grupos prioritários (gestantes, mulheres, crianças, pessoas com doenças crônicas e deficiência);
- Redução das barreiras territoriais e sociais de acesso por meio da expansão e reorganização da rede própria.

Alinhamento PPA:
OE 101 – Atenção a pessoas em vulnerabilidade social.
OE 102 – Acesso à saúde de qualidade.
OE 106 – Inclusão e proteção de grupos vulneráveis.
OE 107 – Atenção às mulheres.
OE 109 – Promoção da igualdade racial.
OE 214 – Redução das desigualdades regionais.

As soluções apresentadas constituem um conjunto integrado de ações que atuam sobre os principais fatores estruturais que limitam o desempenho da rede municipal de saúde. Ao expandir a oferta assistencial, modernizar a infraestrutura, fortalecer a regulação, aprimorar a gestão e priorizar populações vulneráveis, as intervenções propostas criam condições para reorganizar o sistema de saúde de João Pessoa com foco em acesso, qualidade, equidade e sustentabilidade. Além disso, estão plenamente alinhadas às diretrizes do SUS e aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027, ao PMS (2022–2025) e ao Plano de Governo da Prefeitura de João Pessoa (2025-2028) garantindo coerência institucional, aderência às políticas públicas e legitimidade federativa.

1. 2. 59. **Resultado:**

A implementação das soluções propostas permitirá a transformação estrutural, assistencial, institucional e tecnológica da rede municipal de saúde de João Pessoa, produzindo resultados diretos sobre o acesso, a qualidade do cuidado, a eficiência da gestão e a equidade, além de gerar externalidades positivas para o sistema de saúde e para a população de forma mais ampla. Os resultados esperados são observáveis, mensuráveis e alinhados às diretrizes do SUS e aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027.

1. Melhoria do acesso e ampliação da oferta de serviços de saúde

- Redução do tempo de espera para consultas, exames, procedimentos e internações.
- Aumento da capacidade de atendimento em média e alta complexidade.
- Disponibilização de serviços especializados atualmente indisponíveis ou insuficientes na rede própria.
- Maior cobertura territorial e funcional da rede assistencial.

Esses resultados contribuirão para garantir acesso mais oportuno e equitativo à população, reduzindo a demanda reprimida e promovendo maior integralidade do cuidado.

2. Aumento da resolutividade e da qualidade do cuidado

- Melhoria dos desfechos clínicos, como redução da mortalidade hospitalar e de eventos adversos.
- Diminuição do tempo médio de permanência hospitalar por maior eficiência assistencial.
- Maior proporção de atendimentos eletivos em relação às urgências.
- Fluxos assistenciais mais organizados, com continuidade do cuidado entre os níveis de atenção.

Com isso, a rede municipal terá maior capacidade de resolver demandas complexas com segurança, efetividade e foco no usuário.

3. Modernização da infraestrutura física e tecnológica da rede de saúde

- Unidades assistenciais requalificadas, ampliadas ou construídas segundo padrões sanitários, funcionais e tecnológicos atualizados.
- Ambientes acessíveis, seguros, adequados às demandas assistenciais e às normas vigentes.
- Melhor experiência do usuário e melhores condições de trabalho para os profissionais.

A modernização da infraestrutura permitirá maior eficiência operacional e aumentará a capacidade instalada do sistema público.

4. Fortalecimento da gestão, regulação e governança do sistema de saúde

- Estrutura administrativa mais adequada às atribuições da Secretaria Municipal de Saúde.
- Regulação integrada, com monitoramento eficiente de leitos, filas e fluxos.
- Maior capacidade de planejamento, tomada de decisão e avaliação de resultados.
- Melhor articulação entre planejamento, atenção primária, especializada, urgência e hospitais.

Esses avanços fortalecem a governança do sistema e aumentam a capacidade institucional do município.

5. Ampliação da atenção a populações vulneráveis e grupos prioritários

-

Disponibilização de serviços especializados para idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, pacientes crônicos e outros grupos prioritários.

- Redução das desigualdades no acesso entre territórios e perfis populacionais.
- Melhoria da qualidade do cuidado materno-infantil e das condições de saúde da mulher.
- Promoção da inclusão social e garantia de direitos no âmbito da saúde pública.

Assim, a rede de saúde torna-se mais equitativa, humanizada e alinhada às necessidades da população.

6. Maior eficiência e sustentabilidade do sistema de saúde

- Redução da dependência de prestadores privados e filantrópicos em serviços estratégicos.
- Melhoria no uso de recursos públicos por meio de infraestrutura adequada e processos gerenciais mais eficientes.
- Otimização da logística de insumos, medicamentos e serviços de apoio.
- Sustentabilidade financeira e operacional da rede no longo prazo.

Isso favorece a autonomia municipal e o uso racional dos recursos disponíveis.

7. Externalidades positivas e impactos ampliados

Além dos resultados diretos sobre a rede de saúde, espera-se a geração de benefícios mais amplos, tais como:

- Valorização do SUS municipal e fortalecimento da rede regional de saúde.
- Melhoria da confiança da população no sistema público.
- Geração de empregos diretos e indiretos durante a implantação e operação das novas estruturas.
- Aumento da capacidade de resposta a emergências sanitárias e eventos de risco.
- Contribuição para o desenvolvimento social, redução das desigualdades e melhoria da qualidade de vida.

Em síntese, as soluções propostas permitirão transformar a rede municipal de saúde de João Pessoa em um sistema mais acessível, resolutivo, moderno, integrado, inclusivo e sustentável. Os resultados esperados decorrem diretamente das necessidades identificadas no contexto, respondem aos problemas diagnosticados e refletem o impacto positivo das ações estruturantes a serem implementadas, consolidando uma base sólida para a melhoria contínua da saúde pública no município.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral
Transformar a rede municipal de saúde, ampliando a capacidade assistencial, melhorando a qualidade do cuidado e fortalecendo a gestão, para garantir acesso equitativo e sustentabilidade do sistema, em conformidade com as diretrizes do SUS.

(ii) Objetivos Específicos

A) Ampliar e qualificar a oferta de serviços de média e alta complexidade na rede municipal de saúde, por meio da expansão da capacidade instalada e da implantação de serviços especializados, assegurando acesso oportuno, redução de filas e melhoria dos resultados assistenciais.
Indicadores:
I01A: Tempo médio de espera para consulta especializada (dias).
I02A: Tempo médio de espera para cirurgia eletiva (dias).
I03A: Percentual de internações eletivas sobre o total (%).
I4A: Tempo médio de regulação de leito (h)

B) Modernizar, requalificar e expandir a infraestrutura física e tecnológica das unidades de saúde, garantindo ambientes seguros, acessíveis, funcionais e eficientes, adequados às necessidades assistenciais e às condições de trabalho das equipes.
Indicadores:
I01B: Percentual de produção própria vs. contratada em MAC (%)

C) Fortalecer a gestão, a regulação, a governança e a sustentabilidade do sistema municipal de saúde, promovendo a integração entre os níveis de atenção, o aprimoramento dos processos administrativos e logísticos e a ampliação da atenção equitativa às populações prioritárias.
Indicadores:
I01C: Percentual de execução orçamentária da saúde (%)

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**
Nome: I01A: Tempo médio de espera para consulta especializada (dias)

Descrição:
Mede o tempo médio, em dias, entre a data da solicitação e a realização da consulta especializada no Sistema Único de Saúde (SUS). Expressa a oportunidade de acesso à atenção especializada, sendo um indicador sensível à capacidade instalada, à eficiência da regulação e à gestão da fila de espera.

O indicador I01A mensura diretamente o grau de efetividade e equidade do acesso. O tempo médio de espera sintetiza o desempenho sistêmico da rede e reflete dimensões estratégicas da governança em saúde, como eficiência regulatória, adequação da oferta, uso racional de recursos e satisfação do usuário. Reduções sustentadas nesse tempo indicam avanços na assistência à saúde , integração de informações e coordenação do cuidado.
Fontes: SISREG, e-SUS.

Meta:
Reduzir o tempo médio de espera em 30 dias, tomando como linha de base a média de 2025, alcançando o tempo médio em até 60 dias, em 2028.

Linha de base: 90 dias (2025)

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: I02A – Tempo médio de espera para cirurgia eletiva (dias)

Descrição:
O indicador mede o tempo médio, em dias, entre a data de solicitação e a data de realização de cirurgias, em caráter de atendimento eletivo, realizadas na rede pública municipal de João Pessoa ao SUS. Expressa a oportunidade de acesso e a eficiência da gestão cirúrgica, constituindo-se em um dos principais parâmetros de desempenho da atenção hospitalar e especializada.

Ampliar e qualificar a oferta de serviços de média e alta complexidade, com ênfase na expansão da capacidade cirúrgica e na gestão eficiente das filas de espera, assegurando acesso oportuno e equitativo aos procedimentos eletivos. Transforma a rede municipal de saúde, fortalecendo a capacidade assistencial, melhorando a qualidade do cuidado e promovendo sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos públicos.

Fontes: SIH/SUS, SISREG.

Meta:
Reduzir o tempo médio de espera em 90 dias, tomando como linha de base a média de 2025, alcançando 90 dias após o período de 6 meses.

Linha de base: Média 2025 em 180 dias.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: I03A – Percentual de internações eletivas sobre o total (%)

Descrição:
O indicador mede a proporção de internações hospitalares de caráter eletivo em relação ao total de internações realizadas no período. Representa o equilíbrio entre a programação planejada e a demanda espontânea (urgências/emergências), sendo um marcador da eficiência, previsibilidade e organização da atenção hospitalar e da rede de média e alta complexidade.
O indicador reflete a capacidade de planejamento, regulação e organização da rede hospitalar, sendo fundamental para mensurar o grau de previsibilidade e controle do acesso hospitalar.

Fontes de dados: SIH/SUS; SISREG; CNES

Meta:
Aumentar em 20% o número de internações eletivas até o ano de 2028, tomando como linha de base o ano de 2024 (15.646 cirurgias eletivas realizadas), alcançando o total estimado de 18.775 cirurgias eletivas ao final do período.

Linha de base: Representa 100% da produção de referência, correspondente a 15.646 cirurgias eletivas realizadas no período de janeiro a dezembro de 2024, conforme dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e produção aprovada pelo Ministério da Saúde.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: I04A –Tempo médio de regulação de leito (h)

Descrição:
Mede o tempo médio decorrido entre a solicitação de internação e a efetiva ocupação do leito hospitalar pelo paciente, em horas. O indicador avalia a eficiência da regulação hospitalar, a disponibilidade de leitos e a capacidade de resposta do sistema às demandas de urgência e emergência, sendo um importante parâmetro para gestão do acesso e da integralidade do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde (RAS).
A regulação de leitos hospitalares é uma das funções mais sensíveis da gestão do SUS, impactando diretamente a mortalidade evitável, a satisfação dos usuários e a eficiência da rede hospitalar. A demora na regulação está frequentemente associada à ocupação indevida de leitos, falta de integração de informações e comunicação ineficiente entre unidades de saúde, e principalmente, o fato da existência de leitos em serviços que não fazem parte da rede própria.

Meta:
Reduzir em 50% o tempo médio de regulação de leitos até 2029, tomando como referência a linha de base de 2025 (12 horas por paciente), alcançando 6 horas por paciente ao final do período.

Linha de base: Tempo médio de 12 horas por paciente, conforme dados do SISREG.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: I01B – Percentual de produção própria versus contratada em Média e Alta Complexidade (MAC)

Descrição:
Descrição SMART:

S (Específico): Mede a proporção da produção assistencial da rede própria municipal em relação à produção contratada junto a prestadores externos, evidenciando o grau de autonomia e eficiência da rede pública.
M (Mensurável): Os dados são obtidos do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), complementados com registros de contratualização e produção de serviços.
A (Atingível): Aumentar a produção própria é viável mediante investimentos em infraestrutura, ampliação da força de trabalho e incorporação de tecnologias próprias.
R (Relevante): Reduz a dependência da rede contratada, aumenta o controle da qualidade e melhora a eficiência econômica do sistema.
T (Temporal): Monitorado semestralmente e avaliado anualmente, com meta a ser atingida até 2028.
Fontes de dados: SIA/SUS, SIH/SUS, CNES, Relatórios de contratualização, RAG municipal.

Meta:
Meta: Alcançar 80% da produção hospitalar da MAC (Média e Alta Complexidade) realizada na rede própria municipal até dezembro de 2027, considerando o prazo de dois anos de implantação das ações de fortalecimento da rede.

Linha de base 2025: Em 2024, foram registrados 13.071.351 procedimentos, sendo 4.979.213 procedimentos realizados por prestadores terceirizados (ambulatoriais e hospitalares), 8.092.138 na rede própria. (61,9%).

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: I02C – Percentual de execução orçamentária da saúde (%)

Descrição:
DESCRIÇÃO SMART:

S (Específico): Mede o grau de execução orçamentária das ações e serviços públicos de saúde, demonstrando a capacidade da gestão municipal em aplicar os recursos planejados de forma eficaz e tempestiva.
M (Mensurável): Dados provenientes do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), relatórios da Secretaria Municipal de Finanças e relatórios quadrimestrais de gestão.
A (Atingível): A execução plena é alcançável com melhor planejamento financeiro, integração entre as áreas de gestão e adoção de ferramentas de monitoramento orçamentário.
R (Relevante): Indica a capacidade gerencial e a eficiência do gasto público, refletindo o compromisso com a execução do Plano de Saúde, da PAS e das metas do PPA. É também indicador de conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012, que regula os percentuais mínimos de aplicação em saúde.
T (Temporal): Monitorado quadrimestralmente, conforme exigido pela legislação, e consolidado no fechamento anual para avaliação no Relatório Anual de Gestão (RAG).

Meta:
Alcançar ? 90% de execução orçamentária anual da saúde, em 2029.

Linha de base (2025): 80% de execução.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Aprimoramento de Serviços de Saúde Pública
Valor estimado em Dólar (USD): 98.881.800,00

Descrição:
O Componente 1 visa promover a transformação estrutural da rede municipal de saúde por meio da construção, reforma, ampliação, implantação e adequação de unidades assistenciais de média e alta complexidade, bem como da criação de serviços especializados estratégicos para o aumento da capacidade instalada e da resolutividade do sistema junto a modernização na aquisição de equipamentos para a assistência em saúde pública no município de João Pessoa. Essas intervenções respondem diretamente às limitações identificadas no diagnóstico situacional, tais como a insuficiência de leitos públicos, a obsolescência de estruturas físicas, a escassez de serviços especializados, a dependência de prestadores privados, a sobrecarga das urgências e a elevada demanda reprimida por consultas, exames e procedimentos. As ações deste componente estão alinhadas às soluções propostas para ampliar a oferta de serviços, qualificar o cuidado, modernizar a infraestrutura hospitalar, organizar fluxos assistenciais e reduzir desigualdades no acesso. As obras e implantações previstas permitirão a oferta de novos serviços estratégicos (como hemodiálise, oncologia, geriatria, diagnóstico por imagem e cuidados a pessoas com TEA), além de fortalecer hospitais de referência municipal e regional, considerando que João Pessoa é executante de referência para toda a 1ª Macrorregião além de outros municípios da 2ª e 3ª macrorregião de saúde do estado da Paraíba. Dessa forma, o componente contribuirá diretamente para os resultados esperados do programa: ampliação do acesso, redução de filas e tempo de espera, aumento da resolutividade, melhoria dos desfechos clínicos, fortalecimento da rede própria e sustentabilidade do sistema. O componente também reforça a capacidade do município de João Pessoa em assumir seu papel como polo de média e alta complexidade na macrorregião, reduzindo a necessidade de encaminhamentos externos e aumentando a autonomia do SUS municipal. As intervenções estruturais previstas serão desenvolvidas de acordo com normas sanitárias, critérios de segurança, acessibilidade, eficiência operacional e qualidade do cuidado, garantindo ambientes adequados tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 1.1 Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia

Valor estimado: $1.858.000,00

Descrição: A ação compreende a elaboração de estudos técnicos preliminares, projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia necessários para a viabilização das obras estruturantes previstas no Componente 1, incluindo hospitais, policlínicas, bases do SAMU, unidades especializadas e sedes administrativas. Os projetos contemplarão soluções arquitetônicas funcionais, seguras, acessíveis e sustentáveis, conforme normas técnicas vigentes (ABNT, RDC/ANVISA, Corpo de Bombeiros, NBR 9050 e diretrizes de sustentabilidade do Ministério da Saúde). Esses estudos e projetos garantirão a adequada concepção, dimensionamento e planejamento das intervenções, otimizando prazos, custos e qualidade das execuções, além de permitir o detalhamento técnico necessário para as etapas de licitação, contratação e fiscalização das obras. A ação inclui a contratação de consultorias especializadas em engenharia civil, elétrica, hidráulica, sanitária e hospitalar, bem como assessoria técnica para compatibilização e análise de viabilidade ambiental e urbanística.

Meta: Elaborar e aprovar 100% dos estudos e projetos de arquitetura e engenharia necessários às obras do Componente 1 até 2026, garantindo a compatibilidade técnica, legal e ambiental de todas as intervenções.

Da Intervenção

Elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental;

Desenvolvimento de projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia (civil, elétrica, hidráulica, estrutural, climatização e hospitalar);

Compatibilização de projetos com o Plano Diretor de Obras da Saúde e diretrizes do Ministério da Saúde;

Apoio técnico para elaboração de memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e estimativas de custos conforme TCU;

Análise e aprovação técnica dos projetos junto aos órgãos competentes (Vigilância Sanitária, SEMAM, CREA, Corpo de Bombeiros);

Adoção de princípios de sustentabilidade, eficiência energética e acessibilidade universal;

(P) 1.2 Aquisição de equipamentos Hospital oncológico

Valor estimado: $9.960.400,00

Descrição: A ação prevê a aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários técnicos e tecnológicos de alta complexidade para o novo Hospital Oncológico de João Pessoa. A medida é essencial para garantir o funcionamento pleno e a qualidade assistencial da unidade, contemplando desde os setores de diagnóstico e tratamento até as áreas administrativas e de ensino. Os equipamentos previstos incluem itens para o centro cirúrgico oncológico, UTI, hospital-dia, quimioterapia, radioterapia, diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas, anatomia patológica, ambulatórios especializados e suporte terapêutico. Serão priorizados equipamentos com tecnologia de ponta, interoperáveis e compatíveis com os sistemas digitais do SUS, assegurando rastreabilidade, segurança e eficiência na gestão hospitalar.

Meta: Adquirir, instalar e colocar em operação 1.327 equipamentos necessários à implantação (anexo) e funcionamento do Hospital Oncológico até 2028, garantindo a plena capacidade operacional da unidade, conforme cronograma físico-financeiro do projeto.

Da Intervenção

Aquisição de equipamentos médico-hospitalares (diagnóstico por imagem, UTI, centro cirúrgico, oncologia clínica e hospital-dia);

Instalação de sistemas de radioterapia (acelerador linear e suporte de proteção radiológica);

Aquisição de equipamentos laboratoriais e de patologia clínica;

Equipamentos de informática;

Capacitação de equipes para uso, manutenção e gestão dos equipamentos adquiridos;

Implantação de protocolos de manutenção preventiva e corretiva, conforme normas da ANVISA e Ministério da Saúde.

(P) 1.3 – Construção do Hospital Oncológico

Valor estimado: $40.876.000,00

Descrição: O projeto contempla a construção de um hospital geral com vocação oncológica, com área total estimada de 27.000,00m², e capacidade para 150 leitos (incluindo leitos clínicos, cirúrgicos, UTI adulto e oncológicos). O hospital contará com centro cirúrgico oncológico, hospital-dia, quimioterapia, radioterapia (se incorporado), diagnóstico por imagem, patologia clínica, ambulatório especializado e suporte terapêutico. O Hospital oncológico atuará como unidade de referência para tratamento do câncer e atenção a condições de média e alta complexidade, reduzindo a demanda reprimida, o tempo de espera para diagnóstico e tratamento e os encaminhamentos para outros municípios. A construção do HGC impactará diretamente na melhoria dos desfechos clínicos e na redução da mortalidade por câncer.

Com a classificação de prioridade, o serviço assistencial de oncologia hoje no município são dois estabelecimentos filantrópicos: CACON e UNACON, respectivamente: Hospital PB (CNES): 2399741 FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO Hospital PB (CNES): 2399776 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. A ação prevê construir um serviço oncológico municipal na rede própria. Tem-se na rede o Hospital PB (CNES): 0147907 HOSPITAL GERAL E DO CANCER DR STENIO HOLANDA FILHO -HGC (Antigo hospital de COVID, o HOSPITAL PRONTOVIDA), enfrentando problemas de habilitação considerando o prédio ter problemas judiciais sem probabilidade existente de ser ajustado, no momento com prédio em leilão. Assim sendo, a gestão tem como proposta uma construção do serviço próprio de oncologia, e sair desse prédio, podendo garantir a assistência conforme necessidade a toda população do município de João Pessoa e a população referenciada da 1ª macrorregião de saúde do estado da Paraíba.

Meta: Construir e implantar 01 hospital geral com perfil oncológico público no município de João Pessoa integrado às RAS e à Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS. Com a implantação de um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) público, moderno e digitalmente integrado, para atendimento de média e alta complexidade.

Da Intervenção Construção de:

Setor	Estrutura Física (estimada)	Observações
Internação geral e oncológica	150 leitos oncológicos (com 40 cirúrgicos + 20 UTI) - leitos onco Pediátrico e Adulto	Total 150 leitos
Centro cirúrgico	6 salas cirúrgicas (2 oncológicas)	Alta complexidade
Hospital-dia e quimioterapia	30 poltronas	Tratamento ambulatorial
Radioterapia	1 acelerador linear	Habilitação CNES Oncologia
Centro de Diagnóstico por imagem	TC, RM, mamografia digital, ultrassom (proposta de locação de equipamentos)	Diagnóstico e controle
Laboratório de análise clínicas (marcadores tumores); de análise Patologia clínica e anatomia patológica	1 laboratório completo	Diagnóstico e controle

Ambulatório especializado	20 consultórios	Multidisciplinar, Diagnóstico e controle
Administração e ensino/pesquisa	Auditório, biblioteca, salas de residentes	

(P) 1.4 – Construção da Unidade de Referência TEA

Valor estimado: $1.300.600,00

Descrição: Construção de 01 unidade especializada para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com área de 1.392,00 m². A unidade oferecerá diagnóstico, intervenção precoce, terapias multiprofissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia), apoio às famílias e articulação com educação e assistência social. A ação responderá à carência de oferta especializada no município, garantindo inclusão, equidade, integralidade do cuidado e cumprimento das diretrizes nacionais para atenção às pessoas com TEA.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de desenvolvimento neurológico que exige atenção integral, multiprofissional e contínua.

- A ausência de unidades integradas de atendimento a pessoas com TEA compromete o diagnóstico precoce, o acompanhamento terapêutico e a inclusão social.
- A unidade reforçará os princípios da integralidade, equidade e inclusão social, integrando saúde, educação e assistência social.

Meta: Construir 01 unidade pública de referência ao TEA, garantindo acesso, diagnóstico precoce, acompanhamento terapêutico e apoio às famílias.

Da Intervenção:

- Demolição do prédio antigo;
- Reforma estrutural das áreas já existentes (consultórios, recepção, sanitários acessíveis, áreas técnicas);
- Ampliação para implantação de novos espaços funcionais:
  - 06 consultórios multiprofissionais (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, neuropediátrica, enfermagem especializada);
  - 02 salas de integração sensorial e motricidade;
  - 02 salas de terapia em grupo/oficinas;
  - Sala de capacitação e apoio às famílias;
  - Espaço de convivência e recreação terapêutica;
  - Setor administrativo e apoio técnico-operacional (esterilização, almoxarifado, copa, vestiário e sanitários).
  -

02 Elevadores

- Implantação da energia solar

(P) 1.5 – Aluguel de hospital provisório (momento da reforma e ampliação do HMSI)

Valor estimado: $650.300,00

Descrição: Durante a execução das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), será necessária a locação temporária de uma unidade hospitalar provisória, devidamente equipada, para garantir a continuidade dos serviços hospitalares essenciais, especialmente nas áreas de cardiologia, cirurgia geral, retaguarda das UPAS.

Meta: Aluguel de 01 hospital provisório para assegurar a continuidade da assistência hospitalar do HMSI durante o período de reforma e ampliação, mantendo o perfil de atendimento e a qualidade dos serviços prestados à população, sem interrupção das internações e procedimentos hospitalares essenciais.

Da Intervenção

- Locação de imóvel hospitalar adequado, com estrutura física compatível para funcionamento temporário;
- Adequação de instalações provisórias às normas sanitárias da Anvisa e de segurança assistencial;
- Remanejamento de equipamentos e equipes do HMSI para a unidade provisória;
- Garantia de manutenção da oferta de leitos e continuidade das internações de média e alta complexidade;

(P) 1.6 – Reforma e ampliação do Hospital Municipal Santa Isabel

Valor estimado: $18.858.900,00

Descrição: A intervenção consiste na reforma e ampliação do HMSI, unidade hospitalar de média e alta complexidade. O novo hospital contará com ampliação de 70 leitos para retaguarda, além de modernização e adequações físicas, como lavanderia, a central de abastecimento farmacêutica, área externa, fachada e asfaltar área de estacionamento. Com ampliação e reforma do bloco de nefrologia, com 64 cadeiras novas, totalizando 100 cadeiras, ambulatório de pré e pós transplante, junto a implantação de sala cirúrgica para pequenos procedimentos.

O HMSI atuará como hospital geral de retaguarda e referência municipal, fortalecendo a capacidade assistencial e reduzindo a dependência de prestadores externos. Essa ação permitirá reorganizar fluxos assistenciais, ampliar a oferta de procedimentos eletivos, qualificar o cuidado hospitalar e contribuir para a melhoria dos indicadores de mortalidade hospitalar, tempo de permanência e internações por urgência. Com a proposta de mudança de perfil para hospital cardiológico, com serviço em bariátrica, cirurgias gerais, e clínico geral, de média e alta complexidade, necessitando de reforma, ampliação e ajustes de equipamentos para garantir a habilitação com recursos ministeriais a seguir com a produção qualificada o qual se encontra no momento com obsolescência estrutural e tecnológica, comprometendo a segurança e a eficiência assistencial.

Meta: Garantir a 1 ampliação e reforma com qualificação do acesso hospitalar no município, por meio de uma estrutura moderna, segura e resolutiva, promovendo o fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências e da Atenção Especializada, junto à Atenção à Doenças Renal Crônica, alinhada às diretrizes do SUS e às necessidades do território.

Da Intervenção

- Área de ampliação de 7.772,00 m²,com a área da Nefrologia
- Reforma de: 3.454,00m²
- 64 cadeiras de Hemodiálise

- Ambulatório de pré e pós transplantes
- Centro de pequenas cirurgias p fístulas
- lavanderia
- central de abastecimento farmacêutica
- ampliação 70 leitos
- Implantação como Hospital de ensino - residência em coloproctologista, e cardiologia.
- Implantação da energia solar
- pintura da fachada; rebocagem da área de trás e lado direito;
- asfaltar as ruas internas (4.000m²);
- jardinagem

(P) 1.7 - Base do SAMU

Valor estimado: $929.000,00

Descrição: A ação consiste na construção de uma nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) em João Pessoa, estrategicamente localizada para ampliar a cobertura territorial e reduzir o tempo-resposta das ocorrências de urgência e emergência. A intervenção contempla a edificação de estrutura física moderna e sustentável, com áreas administrativas, alojamentos para as equipes, garagem para ambulâncias, central de regulação local e infraestrutura de apoio técnico e logístico para o atendimento pré-hospitalar móvel.

Meta: Construir e implantar 01 Base do SAMU em João Pessoa até 2028, garantindo cobertura operacional integral 24h, com capacidade para abrigar equipes multiprofissionais e frota de ambulâncias tipo A, B e D. A meta inclui reduzir o tempo médio de resposta das ocorrências urbanas para até 10 minutos e das ocorrências periféricas para até 15 minutos.

Da Intervenção

Construção de nova base do SAMU com área total estimada de 1.000,00 m²;

Estrutura física com salas de regulação local, coordenação, repouso adequado e refeitório para equipes;

Garagem coberta com capacidade para xx ambulâncias;

Oficinas e almoxarifado para manutenção de equipamentos e insumos;

Instalação de sistema de energia solar

(P) 1.8 Construção da Policlínica do Idoso

Valor estimado: $1.300.600,00

Descrição: A Policlínica do Idoso será uma unidade especializada de atenção ambulatorial integrada para pessoas com 60 anos ou mais, com área de 1.390,00 m². Oferecerá consultas multiprofissionais (geriatra, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia), exames complementares, reabilitação, acompanhamento de doenças crônicas, prevenção de quedas e cuidado centrado na funcionalidade. Essa unidade responderá diretamente ao envelhecimento populacional e à necessidade de atenção especializada ao idoso, promovendo a continuidade do cuidado, reduzindo hospitalizações evitáveis e melhorando a qualidade de vida dessa população.

A unidade atuará como ponto de atenção secundária, articulada à Atenção Primária, aos Centros de Reabilitação, hospitais gerais e às redes de atenção psicossocial e crônica.

A Policlínica do Idoso constitui um investimento estratégico na reorganização da atenção à saúde da pessoa idosa, promovendo:

- Integralidade e continuidade do cuidado;
- Prevenção de incapacidades e hospitalizações;
- Promoção da funcionalidade e envelhecimento ativo;
- Integração intersetorial com assistência social e cultura;
- Sustentabilidade do SUS diante do envelhecimento populacional.

Meta: Construir e implantar 01 Policlínica do Idoso para atenção ambulatorial especializada, multiprofissional e integrada, com foco em funcionalidade, prevenção e reabilitação.

Da Intervenção Construção:

- Demolição do prédio antigo;
- Consultórios médicos e multiprofissionais (geriatria, enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia);
- Salas de acolhimento, reabilitação e atividades coletivas;
- Sala de observação e curativos;
- Apoio diagnóstico (exames laboratoriais e funcionais básicos);
- Espaço para educação permanente e apoio ao autocuidado
- Implantação da energia solar
- Elevador

(P) 1.9 – Reforma e ampliação do Complexo Hospitalar de Mangabeira Gov. Tarcísio Burity

Valor estimado: $5.574.000,00

Descrição: A intervenção prevê a reforma estrutural e a ampliação do Complexo Hospitalar de Mangabeira, com readequação de áreas físicas, modernização de instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de 30 leitos, unificação do centro cirúrgico com capacidade de 10 cirurgias simultâneas, implantação ou ampliação de UTI com 20 leitos, modernização de equipamentos e reorganização de fluxos assistenciais. A ampliação da unidade permitirá aumento da capacidade hospitalar, melhoria da qualidade assistencial, redução de superlotação e maior resolutividade de urgências e internações. Este hospital é estratégico como referência regional e sua modernização é fundamental para atender a demanda crescente e evitar encaminhamentos externos.

Meta: Reforma e ampliação de 01 Hospital, CHMTB, fortalecendo a capacidade de resposta hospitalar da rede pública, qualificando a atenção às urgências, emergências e internações de média e alta complexidade, com foco na integralidade da assistência, eficiência operacional e segurança do paciente.

Da Intervenção

Reforma estrutural e modernização das instalações físicas

Atualização das redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais;

Ampliação da capacidade instalada, com a área 3.728,00 m²

Requalificação do centro cirúrgico, com a implantação de salas inteligentes e sistemas integrados de monitoramento;

Aquisição e modernização de equipamentos hospitalares, priorizando tecnologia com interoperabilidade digital, conforme diretrizes do Programa SUS Digital 2025-2026;

Reorganização dos fluxos assistenciais e logísticos, com implantação de gestão de risco clínico e protocolos de segurança do paciente;

Implantação da energia solar.

(P) 1.10– Reforma e ampliação do Hospital Municipal Valentina (HMV)

Valor estimado: $5.574.000,00

Descrição: A ação contempla a reforma e ampliação do HMV, unidade de média complexidade, com área de 2.230,00 m² reformada e 1.500,00 m² ampliada, criação ou expansão de 20 leitos, modernização do pronto atendimento, centro cirúrgico, áreas de internação, diagnóstico e apoio. O HMV desempenha papel fundamental na oferta de serviços hospitalares para a população de seu território e para a rede municipal. A reforma e ampliação permitirão melhorar a infraestrutura física, aumentar a capacidade instalada, reorganizar fluxos, reduzir internações por urgência em outras unidades e fortalecer a rede própria de hospitais do município.

Meta: Reforma e ampliação de 01 Hospital, HMV, fortalecendo a capacidade do único hospital pediátrico da gestão própria do município, qualificando o atendimento de média complexidade e a articulação com as redes de atenção à saúde, de modo a aumentar a resolutividade dos serviços locais, reduzir internações evitáveis em outras unidades e garantir o cuidado integral à população adscrita.

Da Intervenção

- Área de reforma: 2.230,00 m² (infraestrutura física existente).
- Área de ampliação: 1.500,00 m² (novas edificações).
- Capacidade instalada após ampliação: criação ou expansão de 20 novos leitos hospitalares.
- Modernização do Pronto Atendimento (urgência e emergência);
- Ampliação e adequação do Centro Cirúrgico (salas, apoio e recuperação anestésica);
- Requalificação das Áreas de Internação (masculina, feminina e pediátrica);
- Atualização das áreas de Diagnóstico e Apoio (imagem, laboratório e farmácia);
- Adequações de acessibilidade, instalações elétricas, hidráulicas e de climatização hospitalar;
- Implantação de sistemas de segurança e controle de infecção (ventilação, isolamento, áreas limpas/sujas).
- Jardinagem
- Asfalto no estacionamento
- Nova Fachada no padrão modernizado

(P) 1.11– Terrenos avaliados para contrapartida

Valor estimado: $12.000.000,00

Descrição: O município de João Pessoa/PB destinou 14 lotes públicos municipais à Secretaria Municipal de Saúde (SMS-JP) como contrapartida para implantação dos 11 produtos estruturantes do projeto RED+JP, que visa à reconfiguração da Rede de Atenção à Saúde, com ampliação da capacidade instalada e qualificação da atenção especializada, hospitalar e de urgência e emergência.

Meta: Construção de 11 produtos do REDS+JP que terá como contrapartida os lotes da Prefeitura do Município de João Pessoa.

Da Intervenção

LOTE	ÁREA	VALOR ESTIMADO(U$)
1	2.300,00	579.072,00
2	5.277,00	582.784,00
3	1.417,50	928.000,00
4	2.579,20	1.057.920,00
5	692,00	454.720,00
6	17.500,00	1.930.240,00
7	5.900,00	616.192,00
8	3.707,68	389.760,00
9	3.036,00	204.160,00

10	6.250,00	426.880,00
11	17.408,00	3.452.160,00
12	639,46	102.080,00
13	1.960,00	1.002.240,00
TOTAL		11.726.208,00

1. 5. 57. **Informações do 2° componente:**
Nome: Fortalecimento Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 21.181.200,00

Descrição:

O Componente 2 tem como objetivo modernizar e fortalecer a gestão da saúde pública no município de João Pessoa/PB, promovendo maior eficiência operacional, integração digital, qualificação profissional e certificação da qualidade hospitalar. As intervenções deste componente visam reduzir gargalos administrativos e aprimorar a logística, o controle e a regulação dos serviços de saúde, garantindo maior transparência e eficiência na alocação de recursos.

Os produtos abaixo detalham as ações estratégicas planejadas dentro do Componente 2.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 2.1 - Aluguel de estrutura provisória para atender a Sede

Valor estimado: $278.700,00

Descrição: Durante o período de reforma e modernização da sede da SMS-JP, será necessária a locação temporária de imóvel adequado para garantir a continuidade das atividades administrativas e operacionais da Secretaria. A estrutura provisória deve atender às normas de acessibilidade, segurança e eficiência, permitindo que a SMS mantenha o funcionamento pleno dos setores essenciais e o atendimento ao público.

Meta: Locar 01 imóvel provisório devidamente adaptado e operacional para funcionamento da SMS-JP durante o período das obras, sem prejuízo aos serviços e atividades institucionais.

Objetivo do Componente: Garantir a continuidade dos serviços administrativos e operacionais da SMS-JP durante as obras de reforma e modernização, evitando interrupções e perdas de eficiência.

Da Intervenção:

- Locação de imóvel com estrutura adequada para abrigar todos os departamentos e setores da SMS;
- Adequação mínima das instalações para rede lógica, mobiliário e acessibilidade;
- Garantia de condições sanitárias, elétricas e de segurança;
- Integração do espaço provisório aos sistemas digitais e de comunicação da SMS.

(P) 2.2 - Construção da nova Sede da SMS-JP

Valor estimado: $11.148.000,00

Descrição: A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS/JP), alinhada à nova Lei Ordinária Municipal de 2025, vem promovendo a atualização de sua estrutura organizacional e modelo de gestão, com o objetivo de modernizar processos, integrar áreas e garantir melhor atendimento à população. A atual sede apresenta limitações estruturais, tecnológicas e logísticas incompatíveis com a nova configuração administrativa e as exigências legais dos órgãos de controle (TCU, CGU, MS e CNS). Ademais, o prédio sofreu desgastes e não atende mais aos requisitos de segurança, acessibilidade e eficiência energética. A proposta visa a construção de uma nova sede moderna, sustentável e inteligente, com condições adequadas de trabalho e integração dos serviços essenciais da saúde municipal, incluindo o Complexo Regulador Municipal de João Pessoa. A construção da nova sede da SMS/JP é uma estratégia de fortalecimento institucional, alinhada aos eixos de governança pública, transparência, inovação e qualidade da atenção à saúde, conforme os princípios do SUS e as diretrizes nacionais de planejamento. O projeto contribuirá para consolidar João Pessoa como referência em gestão pública em saúde digital e integrada, garantindo melhores condições para os profissionais e serviços voltados ao cidadão.

Meta: Garantir uma gestão moderna, integrada, eficiente e orientada ao cidadão, por meio da construção de 01 nova sede da SMS/JP.

Relação com a Solução Proposta:

- Unificar e modernizar os espaços administrativos e operacionais da SMS/JP;
- Integrar o Complexo Regulador Municipal (Central Ambulatorial, Central Hospitalar, Central de Urgência e Emergência e Cartão SUS);
- Integrar a Vigilância Sanitária
- Otimizar fluxos de trabalho e fortalecer a governança em saúde;
- Garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e melhoria no atendimento à população;

Da Intervenção

Fortalecer a capacidade institucional e gerencial da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando a eficiência administrativa, a integração de processos e a qualidade do atendimento ao cidadão.

- Demolição do prédio em uso;
- Adequação estrutural ao novo organograma, elétrica, hidráulica e de rede lógica;
- Instalação de sistemas de energia solar e climatização inteligente;
- Implantação de rede de fibra óptica e integração digital com unidades da rede;

Localização

O projeto segue no terreno atual a ser demolido para nova construção.

(P) 2.3 - Capacitação e Educação Permanente em Gestão da Saúde

Valor estimado: $5.109.500,00

Descrição: Implementação de um programa de capacitação e educação permanente voltado à formação e atualização de 2.750 profissionais de saúde por ano, ao longo de quatro anos, com foco em gestão hospitalar, planejamento em saúde, regulação, auditoria, governança clínica, economia da saúde e gestão de riscos.

Meta: Capacitar 11.000 profissionais até 2030 (2.750/ano), em diferentes níveis de gestão e assistência. Certificar ao menos 80% dos participantes com aproveitamento superior a 70%. Implementar 05 programas de educação permanente alinhados às necessidades identificadas no Plano Municipal.

Objetivo do Componente: Aprimorar a governança e a capacidade de gestão do SUS, qualificando gestores e trabalhadores para o planejamento, execução e avaliação de políticas públicas de saúde, com base em evidências científicas, indicadores de desempenho e metodologias de melhoria contínua.

Da Intervenção

Por ano, 2.750 profissionais, totalizando 11.000 profissionais.

Modalidades de execução:

-

Cursos de curta e média duração (40h a 180h);

- Programas de certificação em gestão pública e hospitalar;
- Oficinas regionais de planejamento e governança clínica;
- Implementação de plataforma digital de aprendizagem contínua.

(P) 2.4 - Construção das sedes administrativas dos Distritos Sanitários

Valor estimado: $4.645.000,00

Descrição: As sedes dos Distritos Sanitários (DS) de João Pessoa atualmente funcionam em imóveis locados e sem infraestrutura adequada para garantir a plena execução das funções de gestão territorial, vigilância em saúde e apoio técnico às equipes da Atenção Primária. O projeto propõe a construção de seis sedes próprias em modelo arquitetônico padronizado, sustentável e acessível, integradas à rede da Secretaria Municipal de Saúde e com infraestrutura para ações intersetoriais e coordenação da Rede de Atenção à Saúde.

Meta: Construir e colocar em funcionamento 06 sedes de Distritos Sanitários até 2029, equipadas e conectadas ao sistema de informação municipal.

Objetivo do Componente: Fortalecer a gestão descentralizada do SUS no território, ampliando a capacidade administrativa, técnica e logística dos Distritos Sanitários para coordenar a Atenção Primária, Vigilância em Saúde e as Redes de Atenção de forma integrada e eficiente.

Da Intervenção

Construção das 06 sedes administrativas de distritos com 600,00m² de área cada, de forma padronizadas, em áreas estratégicas junto às unidades de saúde da área.

1. 5. 75. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 3.937.000,00

Descrição:
O Componente 3 tem como objetivo estruturar e fortalecer a governança do Reorganização e Expansão a garantir o Direito à Saúde em João Pessoa - REDS+JP, garantindo sua gestão eficiente e monitoramento contínuo. A implementação desse componente envolve a criação de mecanismos de planejamento, supervisão e avaliação de impacto das ações executadas, assegurando transparência e efetividade na aplicação dos recursos.

A administração e avaliação do programa permitirão a adoção de boas práticas na execução das iniciativas, viabilizando o acompanhamento dos resultados e a implementação de ajustes necessários para otimizar o desempenho do programa.

Esse componente também prevê a contratação de equipe técnica qualificada para apoiar a gestão do REDS+JP, além da realização de estudos de impacto e monitoramento das ações previstas.

Objetivo do Componente: Garantir a estruturação, o gerenciamento e o acompanhamento contínuo do REDS+JP, promovendo maior controle e eficiência na execução do programa e assegurando que os investimentos realizados resultem em melhorias efetivas na rede de saúde estadual.

Relação com a Solução Proposta: A implementação desse componente responde à necessidade de fortalecimento da gestão do programa, garantindo um acompanhamento rigoroso das ações e possibilitando a correção de eventuais desvios na execução. O desenvolvimento de estratégias de monitoramento e avaliação permite uma gestão mais transparente e eficiente, promovendo a utilização otimizada dos recursos disponíveis.

Relação com os Resultados Esperados: A estruturação adequada da administração e avaliação do programa possibilitará uma implementação mais eficaz das ações previstas no REDS+JP, permitindo a mensuração dos impactos alcançados e a melhoria contínua das políticas públicas de saúde. Entre os principais resultados esperados,

destacam-se:

- Maior eficiência na gestão e execução do programa.
- Monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho.
- Melhor transparência na aplicação dos recursos.
- Identificação de boas práticas e oportunidades de melhoria.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 3.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social

A supervisão técnica, ambiental e social será realizada por empresa de consultoria especializada contratada pelo Município, com a finalidade de assegurar a conformidade das obras, instalações e serviços do Programa com os projetos executivos, especificações técnicas, normas sanitárias aplicáveis, legislação vigente e requisitos ambientais e sociais do BID. A supervisão abrangerá todas as intervenções do Programa, incluindo construção, reconstrução, reforma e ampliação de unidades de saúde, implantação de serviços especializados e instalações complementares.

A consultoria atuará de forma integrada com a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e com a fiscalização do Município, executando, no mínimo, as seguintes atividades.

1. Disponibilizar equipe técnica multidisciplinar e pessoal de apoio para acompanhar a implantação e execução das intervenções, incluindo especialistas em engenharia civil, arquitetura, instalações prediais (elétrica, hidrossanitária, gases medicinais, climatização), segurança contra incêndio, planejamento e custos, além de especialistas ambientais e sociais.

2. Realizar acompanhamento e controle físico, técnico e de qualidade das obras e instalações, verificando medições, conformidade com projetos, compatibilização de disciplinas, atendimento a requisitos de acessibilidade, funcionalidade assistencial e segurança do paciente.

3. Validar cronogramas físico-financeiros, registrar evolução de avanço físico, identificar desvios e recomendar medidas corretivas, com comunicação imediata à UGP em caso de não conformidades, riscos de atraso, problemas de qualidade ou eventos críticos.

4. Coordenar e verificar o Plano de Gerenciamento Ambiental e Social das obras, incluindo controle de poeira, ruído, tráfego, segurança de canteiro, gestão de resíduos da construção, destinação adequada de resíduos e efluentes, e, quando aplicável, aspectos específicos de saúde, como gestão de Resíduos de Serviços de Saúde e medidas de controle de infecção durante a execução de obras em unidades em funcionamento.

5. Monitorar condições de trabalho, saúde e segurança ocupacional, cumprimento de obrigações trabalhistas e a implementação de medidas de prevenção de acidentes, com registro de ocorrências e recomendações.

6. Apoiar a gestão de interface com a comunidade e usuários, incluindo sinalização, comunicação de obras, organização de acessos e funcionamento provisório de unidades, quando necessário, bem como apoiar a implementação de mecanismos de ouvidoria e tratamento de reclamações relacionadas às obras.

7. Executar ensaios e verificações de qualidade compatíveis com obras prediais e instalações de saúde, por meio de laboratórios e testes aplicáveis, incluindo controle tecnológico de concreto e argamassas, testes de estanqueidade, comissionamento de sistemas prediais críticos, aferições de desempenho e conformidade de instalações.

8. Emitir laudos e pareceres técnicos relativos aos serviços executados, incluindo registros fotográficos, checklists de conformidade, relatórios de não conformidade e planos de ação.

9. Elaborar relatórios mensais de acompanhamento consolidando avanço físico, medições, resultados de testes e verificações, riscos e pendências, comparativo com cronograma e orçamento, e recomendações gerenciais para a UGP.

10. Subsidiar a UGP nos processos de recebimento provisório e definitivo, com verificação de “as built”, manuais, garantias, treinamento operacional e plano de manutenção dos sistemas implantados, quando aplicável.

Valor estimado: US$ 2.787.000,00.

(P) 3.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Este produto financiará o apoio técnico, administrativo e especializado necessário para estruturação e funcionamento da UGP, responsável pela coordenação, planejamento, gestão e monitoramento do Programa, assegurando o cumprimento das disposições do Contrato de Empréstimo do BID e a execução eficiente das ações.

O apoio à UGP compreende, no mínimo.

1. Apoio à gestão de aquisições e contratações conforme políticas e procedimentos do BID, incluindo elaboração de planos de aquisições, termos de referência, especificações técnicas, minutas, gestão de contratos e acompanhamento de entregas.

2. Apoio à gestão financeira e contábil do Programa, incluindo desembolsos, controle orçamentário, conciliações e prestação de contas.

3. Apoio ao monitoramento e avaliação, incluindo consolidação de informações, acompanhamento de indicadores e resultados, elaboração de relatórios gerenciais e apoio à preparação de missões e revisões do BID.

4. Apoio à gestão ambiental e social, garantindo integração dos requisitos E&S aos processos de contratação, supervisão e execução, incluindo instrumentos de gestão, monitoramento e registro.

5. Apoio jurídico-administrativo, comunicação institucional e transparência, incluindo rotinas de divulgação de informações e articulação intersetorial.

6. Apoio à gestão de riscos, integridade e controles internos, com mecanismos de prevenção e tratamento de inconformidades.

Valor estimado: US$ 1.000.000,00.

(P) 3.3 - Avaliações do Programa

Este produto financiará a realização de avaliações do Programa, com a finalidade de verificar o grau de alcance dos resultados e a efetividade das intervenções, subsidiando decisões de ajuste durante a implementação e a prestação de contas ao BID e à sociedade.

Valor estimado: US$ 50.000,00

(P) 3.4 - Auditoria Externa

Este produto financiará a contratação de auditoria externa independente para verificar a execução financeira e a conformidade do Programa, com emissão de relatórios anuais ao longo da implementação, em conformidade com o Contrato de Empréstimo e os requisitos do BID.

A auditoria contemplará, no mínimo.

1. Revisão das demonstrações financeiras do Programa, conciliações, desembolsos e comprovações.

2. Verificação de aderência a normas e procedimentos aplicáveis, incluindo controles internos e rastreabilidade de gastos.

3. Avaliação de aspectos operacionais e administrativos relevantes para a boa governança do Programa.

4. Emissão de relatórios anuais com conclusões, recomendações e plano de ação para eventuais ajustes, reforçando transparência e accountability.

Valor estimado: US$ 100.000,00.

1. 6. **Beneficiários**

O público-alvo prioritário do projeto reflete o compromisso com a equidade, o fortalecimento do SUS e a redução das desigualdades em saúde. As ações estruturais e institucionais visam suavizar carências assistenciais, socioeconômicas e territoriais, ampliando o acesso, a qualidade do cuidado e a sustentabilidade do sistema municipal de saúde de João Pessoa.

Os grupos beneficiários e suas características são os seguintes:

- Idosos (? 60 anos) = ~14% da população (?120 mil pessoas)

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Necessidade de atenção multiprofissional, reabilitação e cuidado contínuo.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da Policlínica do Idoso com a ampliação de oferta de serviços geriátricos.

- Pessoas com Doenças Crônicas e Condições Oncológicas = Estimados 35 mil pacientes ativos na rede municipal.

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Falta de leitos e serviços oncológicos próprios; dependência de prestadores externos.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção do Hospital Oncológico e fortalecimento do HMSI.

- Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiências Intelectuais = ~5.000 pessoas (crianças e adultos)

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Falta de diagnóstico precoce, terapias multiprofissionais e apoio às famílias.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da Unidade de Referência TEA

- Usuários do SUS com demandas de urgência e emergência = Média de 450 mil atendimentos/ano

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Necessidade de tempo-resposta adequado e estrutura física moderna.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da Base do SAMU e ampliação da rede hospitalar.

- Servidores do município de João Pessoa

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Necessidade de capacitação contínua e modernização da gestão.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da nova Sede da SMS-JP e programas de Educação Permanente.

1. 12. **Anexos**

PLANO DE GOVERNO - João Pessoa no caminho Certo 2024

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa REDS+JP está integralmente alinhado às prioridades do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, com destaque para a Área Estratégica IV - Saúde: atenção primária e especializada, conforme o §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024.

Objetivos Estratégicos do PPA relacionados ao Programa:

OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do SUS

- O objetivo geral do projeto está diretamente alinhado ao OE 102, ao propor transformar a rede municipal de saúde, ampliar a capacidade assistencial, melhorar a qualidade do cuidado e fortalecer a gestão, em conformidade com as diretrizes do SUS.
- Os objetivos específicos A (ampliar e qualificar a média e alta complexidade), B (modernizar e expandir a infraestrutura) e C (fortalecer a gestão e a regulação) contribuem diretamente para o fortalecimento da rede pública.
- Os indicadores definidos no Pleito: tempo de espera para consultas especializadas (I1A), tempo de espera para cirurgias eletivas (I2A), percentual de internações eletivas (I3A), tempo de regulação de leitos (I4A) e percentual de produção própria vs. contratada (I01B); possibilitam mensurar avanços efetivos na ampliação do acesso e na qualidade da atenção especializada.
- O Componente 1, que concentra aproximadamente 77% dos recursos totais do programa, reúne ações diretamente ligadas ao fortalecimento do SUS: construção e ampliação de hospitais, criação de unidades especializadas (oncologia, TEA, idoso), fortalecimento da urgência e emergência (Base SAMU) e estudos/projetos estruturantes.
- O programa contribui para reorganizar fluxos assistenciais, reduzir tempos de espera, ampliar a oferta própria em média e alta complexidade e melhorar a capacidade de resposta da rede municipal de saúde.

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em equipamentos sociais e infraestrutura

- O projeto promove ampliação e modernização da infraestrutura social urbana por meio da construção e qualificação de equipamentos públicos de saúde distribuídos no território municipal.
- Os objetivos específicos A e B estão diretamente relacionados ao OE 111, pois tratam da criação, reforma e ampliação de unidades assistenciais que integram a rede de equipamentos sociais da cidade.
- Os indicadores de acesso e organização da rede (I1A, I2A, I3A, I4A, I01B) demonstram o uso ampliado e eficiente da infraestrutura implantada ou requalificada.
- Os componentes do projeto voltados a hospitais, policlínicas e unidades especializadas contribuem para melhorar a acessibilidade territorial aos serviços de saúde e reforçar a infraestrutura social urbana.

OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

- O projeto contribui para o OE 214 ao fortalecer João Pessoa como polo regional de média e alta complexidade, ampliando a capacidade de atendimento para populações de municípios vizinhos que utilizam a rede municipal

como referência.

- Os objetivos específicos A e B ampliam a oferta de serviços especializados e reforçam a infraestrutura hospitalar utilizada de forma regionalizada.

- Os indicadores de acesso e organização assistencial (I1A, I2A, I3A, I4A) demonstram a melhoria do acesso à atenção especializada e hospitalar, beneficiando também usuários de fora do município.

- Os componentes ligados ao Hospital Oncológico, unidades especializadas e hospitais municipais possibilitam ampliar a equidade territorial na oferta de serviços de saúde.

OE 302 – Promover o aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestação de serviços públicos de qualidade

- O objetivo geral do programa incorpora o fortalecimento da gestão como eixo central, o que se relaciona diretamente ao OE 302.

- O objetivo específico C aborda a qualificação da gestão, da regulação e da sustentabilidade do sistema, contribuindo diretamente para ampliar capacidades institucionais.

- Os indicadores de gestão e eficiência (I01C – execução orçamentária da saúde) permitem avaliar o aprimoramento da capacidade de planejamento, execução e monitoramento da política de saúde.

- O Componente 2 fortalece a gestão pública ao prever: construção da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, construção das sedes dos Distritos Sanitários, capacitação e educação permanente, além de instrumentos de governança (UGP, supervisão técnica, avaliações e auditoria).

OE 303 – Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo

- O programa se relaciona de forma indireta ao OE 303, na medida em que a gestão e a regulação utilizam sistemas de informação em saúde já existentes, necessários para monitorar indicadores como regulação de leitos (I4A), produção assistencial (I01B), e execução orçamentária (I01C).

- A melhoria dos processos de gestão e regulação previstos no objetivo específico C reforça o uso sistemático de informações estruturadas, ainda que não estejam previstas novas soluções digitais no escopo do programa.

OE 306 – Assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova justiça social e ampliação de investimentos

- O programa contribui para o OE 306 ao promover maior sustentabilidade do sistema municipal de saúde por meio da ampliação da produção própria e da redução da dependência de serviços contratados.

- Os indicadores I01B, e I01C permitem avaliar ganhos de eficiência, e melhoria da execução orçamentária.

- Os componentes voltados à ampliação da oferta própria em média e alta complexidade e ao fortalecimento institucional apoiam um modelo assistencial mais eficiente e sustentável no longo prazo.

OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social

- O programa contribui de forma transversal para o OE 106 ao ampliar o acesso a serviços essenciais direcionados a grupos vulneráveis: pessoas idosas, pessoas com TEA, pacientes oncológicos, mulheres e crianças.

- Os objetivos específicos A e B tratam da criação de unidades especializadas e da melhoria da infraestrutura hospitalar, que beneficiam diretamente populações em situação de maior vulnerabilidade em saúde.

- Os componentes de implantação de unidades especializadas (Policlínica do Idoso, Unidade TEA, Hospital Oncológico) e qualificação da urgência e emergência (Base SAMU, hospitais ampliados) fortalecem a proteção de direitos e ampliam o acesso de grupos prioritários.

2. 27. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do projeto REDS+JP contará com a participação de diversas instituições municipais e parceiras, que atuarão de forma integrada para garantir a execução eficiente, a transparência e a sustentabilidade das ações planejadas.

1. Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Papel: Órgão executor e responsável pela governança geral do projeto.
Atribuições:

- Planejar, coordenar e supervisionar todas as etapas do projeto.
- Promover a integração das ações entre os setores administrativos, financeiros e operacionais.
- Assegurar o alinhamento às diretrizes do Plano Municipal de Saúde e do Plano Anual de Saúde - PAS vigente.

2. Chefia de Gabinete da SMS

Papel: Instância de assessoramento estratégico e articulação política.
Atribuições:

- Apoiar tecnicamente o Secretário Municipal de Saúde.
- Promover o alinhamento intersetorial e a comunicação institucional.
- Monitorar a execução das metas e apoiar a tomada de decisão.

3. Procuradoria Geral do Município - Procuradoria Setorial _ PROSET

Papel: Órgão de controle interno do projeto.
Atribuições:

- Fiscalizar a execução física e financeira.
- Analisar conformidade documental e orçamentária.
- Supervisão da integridade, conformidade e transparência

4. Diretoria Administrativa-Financeira

Papel: Unidade responsável pela gestão administrativa e financeira.
Atribuições:

- Coordenar as áreas de Licitações e Aquisições, Gestão de Pessoas, Administração e Finanças.
- Coordenar as áreas de engenharia.

5. Diretoria de Planejamento e Gestão

Papel: Núcleo de planejamento, monitoramento e avaliação.
Atribuições:

- Estruturar o sistema de monitoramento e indicadores do projeto.
- Elaborar relatórios de desempenho e relatórios de gestão.
- Conduzir processos de avaliação.

6. Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Papel: Responsável pela execução técnica das ações em campo.
Atribuições:

- Coordenar os Componentes do programa.
- Monitorar cronogramas, metas e resultados operacionais.
- Relatar avanços e desafios à Diretoria de Planejamento e à Chefia de Gabinete.

3. 1. 19. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Saúde (SMS JP)
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas – SESOP
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA
Procuradoria Geral do Município – PGM
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Instituto de Planejamento de Cascavel – IPC

3. 1. 20. **Estrutura Operacional:**

A execução do projeto REDS+JP será conduzida por instituições que possuem comprovada capacidade técnica e administrativa, assegurando a implementação eficaz e coordenada das ações planejadas.

A SMS JP, como órgão executor do programa, possui experiência consolidada na gestão de projetos voltados para a melhoria da infraestrutura e serviços de saúde pública. A Equipe técnica qualificada composta por profissionais de áreas estratégicas para execução do Programa, tais como:

Unidade / Diretoria	Principais Atribuições	Composição da Equipe	Quantidade de pessoas

Gabinete do Secretário	Coordenação geral do projeto, articulação interinstitucional, comunicação estratégica e tomada de decisão.	Secretário Municipal, Secretária Executiva e Assessores	4
Diretoria de Planejamento e Gestão	Alinhamento do projeto ao Plano Municipal de Saúde e PPA; análise de metas e priorização de investimentos. Formulação, monitoramento e avaliação do plano de trabalho; gestão de indicadores e metas.	Gestor de Políticas Públicas e Administrador.	2
Diretoria de Contratação Pública	Condução de processos licitatórios	Pregoeiro, Analista de Compras, Advogado e Técnico Administrativos.	4
Diretoria de Finanças e Administração	Execução orçamentária e financeira do projeto, controle contábil e prestação de contas, engenharia, almoxarifado, manutenção.	Contadores, Engenheiros, Controladores Internos, técnicos administrativos.	6

Diretoria da Atenção Básica	Coordenação das unidades de atenção primária, contendo as sedes de Distrito Sanitários.	Diretora A.B. e gerentes dos Distritos Sanitários.	2
Diretoria da Atenção Especializada	Gestão dos serviços especializados	Diretora da especializada e gerentes das policlínicas	2
Diretoria da Atenção Hospitalar	Gestão dos serviços hospitalares de média e alta complexidade	Diretor Hospitalar e Gestores Hospitalares	2
PROSET – Coordenação de Controle e Fiscalização	Controle interno, auditoria, verificação de conformidade e acompanhamento de execução física e financeira.	Procurador e Auditor	2

A SMS-JP dispõe de uma estrutura robusta, com equipe técnica multidisciplinar e sistemas de apoio à gestão, assegurando a governança, a rastreabilidade e o controle dos recursos aplicados.

Não haverá repasse direto de recursos entre os órgãos parceiros. Toda a execução orçamentária será centralizada na SMS-JP, sob controle contábil da Secretaria de Finanças (SEFIN) e fiscalização da PROSET, garantindo integridade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

O Município de João Pessoa possui experiência concreta e reconhecida na execução de projetos financiados por organismos internacionais — demonstrando não apenas capacidade de captar recursos, mas também competência técnica e administrativa para realizar projetos de larga escala com impacto social e urbano significativo.

Entre as parcerias de destaque, estão aquelas firmadas com o Ministério da Saúde e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a exemplo do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável de João Pessoa/PB (Financiamento BID), voltado à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população. Essas iniciativas evidenciam a competência do município em alinhar-se às diretrizes nacionais e internacionais de governança, planejamento e avaliação de políticas públicas, e do Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (2020).

Essa trajetória reflete a busca contínua do município por parcerias sustentáveis e inovadoras, orientadas por evidências e comprometidas com a efetividade das ações públicas, fortalecendo sua inserção em redes de cooperação internacional e contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

3. 1. 21. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE REDS+JP.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A implementação do REDS+JP – Reorganização e Expansão a Garantir o Direito à Saúde em João Pessoa prevê a adoção de estratégias robustas para assegurar a continuidade das ações e a sustentabilidade operacional, técnica e financeira após o encerramento do apoio de financiamento externo.

O projeto adota uma abordagem de sustentabilidade integrada, abrangendo todas as fases — concepção, execução, monitoramento e pós-implantação —, assegurando que os investimentos, infraestruturas, equipamentos e serviços implementados mantenham-se plenamente operacionais ao longo do tempo. Com as seguintes estratégias de sustentabilidade operacional, técnica e financeira:

- Incorporação ao Planejamento Municipal: todas as ações e estruturas criadas pelo REDS+JP serão integradas ao Plano Municipal de Saúde (PMS) e à Programação Anual de Saúde (PAS) subsequente, garantindo respaldo orçamentário e institucional permanente.

- Capacitação contínua das equipes: as equipes técnicas e assistenciais envolvidas serão capacitadas em gestão, manutenção de equipamentos, protocolos assistenciais e boas práticas operacionais.

- Manutenção preventiva e corretiva: será instituído um plano de manutenção preventiva e corretiva de obras e equipamentos, coordenado pela Diretoria Administrativa-Financeira, conforme padrões do Ministério da Saúde e da Anvisa.

- Adoção de sistemas de informação integrados: utilização dos sistemas e-SUS, SIA/SIH-SUS e outros que estejam em prática conforme orientações do Ministério da Saúde, que permitirão o acompanhamento contínuo de indicadores e metas de desempenho.

- Monitoramento e avaliação pós-implantação: as ações serão acompanhadas por meio de relatórios semestrais de desempenho, com indicadores de resultado e de sustentabilidade definidos no momento da pactuação.

- Inclusão dos custos de manutenção no orçamento municipal da saúde, garantindo dotação anual específica para custeio de equipamentos, serviços de limpeza, segurança e energia elétrica das novas unidades.

- Aproveitamento das fontes regulares do SUS, como Blocos de Custeio da Atenção Primária e da Média e Alta Complexidade, além de eventuais incentivos do Ministério da Saúde para continuidade da assistência.

- Contratualização de metas assistenciais e orçamentárias com as unidades executoras, promovendo eficiência e controle sobre os gastos.

- Gestão de riscos fiscais, conforme orientações do Manual de Gestão de Riscos, assegurando reservas financeiras e mitigação de eventuais descontinuidades orçamentárias.

A sustentabilidade financeira foi estimada com base na média de custos de manutenção da rede municipal de saúde e nas planilhas referenciais do DATASUS e da Caixa Econômica Federal (PAC Saúde):

Categoria	Descrição	Custo Anual Estimado (U$)	Fonte de Financiamento
Manutenção Predial	Serviços de conservação, limpeza e pequenos reparos nas unidades beneficiadas	140.000,00	Tesouro Municipal / Recursos Próprios
Manutenção de Equipamentos	Calibração, peças de reposição e contratos de manutenção preventiva	78.000,00	Tesouro Municipal / Recursos Próprios
Despesas de Operação	Energia, água, vigilância e serviços gerais	177.000,00	Tesouro Municipal / Recursos Próprios
Total Estimado Anual		395.000,00	

A implantação do REDS+JP representa uma mudança estrutural no modelo de financiamento e gestão dos serviços de saúde no município. Os recursos atualmente destinados à assistência contratualizada passarão a ser investidos diretamente na rede própria, fortalecendo a gestão municipal. Isso garante que os valores sejam aplicados exclusivamente conforme a Tabela SUS, sem complementos ou adicionais contratuais, promovendo maior racionalidade, transparência e sustentabilidade financeira. Estando esse estabelecimento habilitado pelo SUS, com as possíveis vinculações de portarias de custeio.

3. 12. **Planejamento Estratégico**

O Projeto RED+JP está plenamente alinhado ao planejamento municipal de saúde vigente e contribui diretamente para o cumprimento das metas e entregas previstas no Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 vigente (Anexo).

A integração estrutural das ações do projeto à rotina da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com incorporação das atividades e metas aos instrumentos de planejamento municipal — PPA, PMS, PAS (2025) — assegurando a

perenidade institucional.

O Programa está alinhado ao PPA JP (2024-2027) (Anexo) nos seguintes programas:

- Programa 5005 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - páginas 12 a 15 do arquivo anexo.
- Programa 5139 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE IMÓV - página 24 do arquivo anexo.

O RED+JP também endereça compromissos assumidos no Plano de Governo 2026, nas páginas 13 -14.

3. 15. **Anexos**

PLANO DE GOVERNO - João Pessoa no Caminho Certo 2024

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2022 - 2025

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2025

ORGANOGRAMA ARRANJO INSTITUCIONAL REDES+JP

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Atraso na tramitação e aprovação de licenças e autorizações institucionais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Quando há demora na obtenção de aprovações junto a órgãos municipais, estaduais ou federais (como licenças ambientais, autorizações sanitárias e pareceres técnicos), impactando o cronograma de execução do projeto e a liberação de recursos do financiamento internacional. As causas podem incluir entraves burocráticos, ausência de equipes técnicas dedicadas ou sobreposição de competências entre órgãos.

Prevenção e Mitigação:

- Acompanhamento da Comissão Intersetorial da SMS
- Planejamento antecipado das demandas junto aos órgãos licenciadores.
- Monitoramento periódico das pendências via painel de controle do projeto.
  Responsável: Unidade Executora do Projeto / Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

4. 5. **Informações do 2° risco:**
Nome: Elevação dos custos de obras e equipamentos durante a execução.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Em razão de variações inflacionárias, reequilíbrios contratuais e atrasos na execução que resultam em custos adicionais não previstos. Pode comprometer a execução financeira e exigir reprogramação orçamentária.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de critérios de reajuste contratual claros conforme legislação.
Acompanhamento de mercado.

Responsável: Unidade de Gestão do Projeto (UGP)/ Comissão Intersetorial da SMS

4. 6. **Informações do 3° risco:**
Nome: Insuficiência de pessoal técnico qualificado para operação das novas estruturas e sistemas.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A ampliação da rede física e tecnológica poderá demandar profissionais especializados em áreas como engenharia clínica, TI e gestão hospitalar. A falta de capacitação pode gerar baixa utilização dos equipamentos e dificuldades operacionais.

Prevenção e Mitigação:
Execução de plano de capacitação continuada para gestores e equipes técnicas.
Criação de cargos estratégicos via reestruturação organizacional da SMS.
Responsável: SMS

4. 7. **Informações do 4° risco:**
Nome: Atrasos ou falhas em licitações e contratos.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Processos licitatórios complexos, especialmente para obras e equipamentos hospitalares, podem enfrentar impugnações, recursos ou anulações, gerando atrasos significativos na execução do cronograma.

Prevenção e Mitigação:
Padronização de termos de referência e editais tipo BID.
Assessoramento técnico da Procuradoria Geral do Município e controle interno.

Responsável: UGP/Comissão Intersetorial da SMS

4. 8. **Informações do 5° risco:**
Nome: Atrasos na elaboração e aprovação dos projetos de arquitetura e engenharia
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atrasos na entrega, revisão ou aprovação dos projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia, comprometendo o cronograma das obras previstas. As causas incluem falta de alinhamento entre projetistas, falhas de compatibilização técnica, exigências complementares dos órgãos de licenciamento e morosidade nas análises internas.

Prevenção e Mitigação:
- Contratação de equipe técnica de acompanhamento exclusivo (engenharia e fiscalização).
- Realização de revisões técnicas intermediárias com checklist padrão TCU/ABNT.
- Cronograma integrado de validação junto à Vigilância Sanitária, SEMAM e Corpo de Bombeiros.

Responsável: UGP / Secretaria Municipal de Infraestrutura / SMS.

4. 12. **Informações do 6° risco:**
Nome: Dificuldades na aquisição de equipamentos médico-hospitalares
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de desabastecimento ou atrasos na entrega de equipamentos, devido à escassez de fornecedores, problemas logísticos ou restrições cambiais. Pode comprometer a operacionalização do Hospital Oncológico e demais unidades.

Prevenção e Mitigação:
- Planejamento antecipado das licitações com fase preparatória robusta (TCU, 2020).
- Contratos com cláusulas de performance e garantias contratuais de entrega.
  Responsável: UGP / Setor de Compras / SMS.

4. 15. **Informações do 7° risco:**
Nome: Restrições e atrasos na execução de obras em prédio tombado
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Ocorre quando as intervenções em edifício ou terreno sob proteção do patrimônio histórico, artístico ou cultural enfrentam restrições técnicas e legais impostas por órgãos de preservação, o que pode afetar o cronograma, elevar custos e exigir alterações de projeto. As exigências de conservação, métodos construtivos específicos e necessidade de acompanhamento arqueológico podem gerar atrasos, aumento de custos e necessidade de readequação contratual.

Prevenção e Mitigação:

- Aprovação prévia e acompanhamento contínuo

- Planejamento de contingência financeira e temporal para eventuais revisões de projeto

Responsável: UGP / Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria de Infraestrutura

4. 18. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	99.200.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	24.800.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
SOFR + margem de fundo em relação a SOFR (0,41% para o 1º trimestre 2025) + acrescida de spread de crédito (0,80% para o ano de 2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
0,5% semestral do valor do saldo do desembolso
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Aprimoramento de Serviços de Saúde Pública					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
13.376.000,00	2.355.658,00	26.491.900,00	7.350.300,00	28.229.600,00	5.657.342,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
8.007.500,00	4.048.500,00	3.365.000,00	0,00		

Nome do componente					
Fortalecimento Institucional					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
8.600.000,00	1.500.000,00	3.193.000,00	888.200,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
250.000,00	0,00	725.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
905.000,00	0,00	632.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

1. receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;

2. recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e

3. recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como estágio prévio das ações do referido Projeto, o município de João Pessoa vem aplicando ações que contemplam a escala de prioridade para o aprimoramento de Serviços de Saúde Pública e fortalecimento institucional.

O município de João Pessoa vem oferecendo ampliação na rede de atenção primária, com CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, de forma a garantir boas condições na assistência à saúde. Assim como a construção do CER IV garantindo assistência para a linha de cuidado com deficiência. Sendo implantado um novo serviço de assistência a garantir a retaguarda e ampliar a oferta, HOSPITAL DIA IRMÃ BEATRIZ FRAGOSO.

Em 2025, o município de João Pessoa foi contemplado com recurso ministerial (PAC) para a construção de uma Maternidade, com previsão de início no primeiro semestre de 2026, já possuindo o terreno, e com projeto arquitetônico pronto. Garantindo assim, melhor assistência, com ampliação de leitos e serviços para atendimento da rede materno infantil, no cuidado ampliado para redução de morte materna, além de ser aquisição de um serviço de gestão própria. Essa construção vem no momento de grande importância, considerando que a morte materna em 2025, João Pessoa registrou 15 mortes maternas (sendo apenas 03 residentes), o que representa mais da metade dos casos do estado.

No ano de 2025, a SMS vem aplicando a nova Lei Ordinária contemplando a nova estrutura administrativa e organizacional. A atualização do ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de João Pessoa (SMS/JP) representa uma iniciativa fundamental para o fortalecimento da gestão pública em saúde, diante de um cenário institucional que há quase duas décadas necessitava de adequações formais compatíveis com as transformações vivenciadas no Sistema Único de Saúde (SUS), nas legislações nacionais e nas exigências dos órgãos de controle. Reafirmando o compromisso da SMS/JP com a melhoria contínua da atenção à saúde e com a construção de políticas públicas sustentadas na legalidade, na equidade e na eficiência, pensa-se no colaborador bem estruturado e com condições físicas, tecnológicas e possível de aplicar o melhor atendimento ao cidadão.

Essas ações demonstram o compromisso do Município de João Pessoa/PB com o fortalecimento da rede de saúde, e evidenciam que o REDS+JP está alicerçado em etapas prévias concretas e articuladas com políticas públicas nacional, estadual e municipal conferindo maior viabilidade e sustentabilidade à sua execução.

6. 2. Anexos

Sem anexos.